



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سهام محمد محمد عوض الله
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العياط
رقم البطاقة : 26201012100128 رقم التليفون : 01114686608
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-01-1962 المهنة : بدون عمل
العنوان : =====
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ بالصبغة [12771] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سهام محمد محمد عوض الله National ID: 26201012100128	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Contrast-enhanced MRI of the brain.
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DM5
١٩٥١
٢٠١٢



Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. CT CAP+C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

٣١٧٨

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported breast carcinoma , compared to last study dated on 15/10/2025 .

(I) Chest:

- Right mastectomy with clear operative bed .
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- Right upper lobe and middle lobe subpleural reticulations likely post radiotherapy.
- Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size showing homogenous CT density , no focal lesions
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Still noted right lumbar subcutaneous nodule 18 x 15 mm .

Name: سهام محمد محمد عوض الله			
MR. : 3178			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الخروج :		تاريخ وساعة الدخول :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient is under follow-up for supportive treatment after a prior assessment of CTCAP in October 2025. A free bone scan was performed in September 2025 and a free MRI of the brain was completed on 30 November 2025. The most recent assessment noted stable disease (SD) and the patient was advised to continue surveillance. The patient's oncologic history includes right-sided breast cancer treated with radiotherapy and mastectomy in 2014, followed by gemzar and taxol. In 2016, a cerebellar sub-total resection was performed, followed by whole-brain irradiation and then xeloda/tykerb starting in January 2024. The patient has been receiving DP-f (herceptin/tykerb/xeloda) since September 2024. In September 2024, a multidisciplinary team (MDT) recommended discontinuation of all active treatment and continued surveillance with CT CAP and brain MRI every six months. A CT CAP performed in April 2026 showed stable disease, and an MRI brain in April 2026 revealed bilateral foci of lacunar infarcts with no evidence of ischemic insult, but noted left cerebellar encephalomalacia. Follow-up is planned after four months.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 19-09-2026	
الوقت :		الطبيب المعالج : Reham Ahmed Fathy Ibrahim	
يعتمد ,			

Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. CT CAP+C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Small sized right kidney 5 x 2.2 cm with compensatory hypertrophy of left kidney .
- Normal CT appearance of the pancreas, aorta and IVC.
- Normal CT appearance of the spleen .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions ..
- No vertebral structural collapse .

OPINION:.

Overall stationary course

Dr.Reham Khedr, MD

Patient's Name: SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAAD ALLAH
Date: 2026-04-19
Referred by: Prof.Dr. MRI BRAIN + C
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MRI OF THE BRAIN WITH CONTRAST

Findings:

- Involutional brain changes in the form of prominent sub arachnoid spaces
- Few foci of altered signal intensity are seen in both frontal regions displaying high T2 & FLAIR signal intensities
- Small area of cystic encephalomalacia is noted at left cerebellar hemisphere .
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of deformity or displacement.
- No cerebellar or brain stem areas of abnormal signal intensity
- No mid line shift.
- No extra-axial collections.
- **OPINION:**

Bilateral frontal foci of lacunar infarcts , no evidence of recent ischemic insult

Left cerebellar encephalomalacia .

Dr. Reham khedr ,MD

CAIRO UNIVERSITY
FACULTY OF MEDICINE
PATHOLOGY DEPARTMENT

Pathology No: 3267

Age: 53

Sex: female

Name *Amr Mohamed Elmaghrabi*

Clinical diagnosis Cerebellar SOL

Hospital no:

Nature of specimen Excision biopsy

Department: 25

Date: 23/05/2018

PATHOLOGY REPORT

GROSS:

Two soft tan tissue pieces: 2.5x1.5 cm & 2.5x1 cm. Totally submitted.

MICROSCOPIC:

Examination of the specimen received revealed multiple tissue fragments infiltrated by malignant epithelial growth formed of sheets, nests, cords & tubules of moderately anaplastic cells. The surrounding stroma is fibrotic. Wide areas of necrosis were detected.

DIAGNOSIS

Cerebellar SOL; excision:

Metastatic moderately differentiated adenocarcinoma.

PROF DR. MAHA MOSAAD
DR. SAMAR AMER

Amr Mohamed Elmaghrabi



وحدة دلائل الأورام
قسم الباثولوجيا - القصر الطبي
ب - ١١٦٤٩٦١٤

IMMUNOHISTOPATHOLOGY

Patient Name: سها محمد محمد

Lab.No: 2016-513

Date: 4/2016

Sex: F

Markers: ER, PR, HER 2 neu and Ki67

Procedure:

Sections were prepared from paraffin blocks treated for (ER, PR, HER 2 neu and Ki67) automatically stained in Bench mark GX (VENTANA) using view dab Detection Kit. Hematoxylin as counter stain

Result:

Examination of sections for ER and PR revealed no nuclear staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for HER2 neu revealed positive membranous staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for Ki67 revealed positive nuclear staining about 40% of tumour cells by chromogen

DIAGNOSIS:

NEGATIVE FOR ER AND PR

POSITIVE FOR HER2NEU (CLASS 3+)

HIGH PROLIFERATION INDEX

PROF. DR. SAMIA GABAL

Name : seham mohamed mohamed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 01-09-2025 12:02
Medical No. : 191839

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 63-year-old lady, with history of right breast cancer, referred for metastatic workup.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease could be seen allover the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine

Patient's Name:

SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL

Date:

2026-04-19

Referred by:

Prof.Dr. CT CAP+C

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

2177

MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction. IV contrast was used.

FINDINGS:

Clinically reported breast carcinoma , compared to last study dated on 15/10/2025.

(I) Chest:

- Right mastectomy with clear operative bed .
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- Right upper lobe and middle lobe subpleural reticulations likely post radiotherapy.
- Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size showing homogenous CT density , no focal lesions
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Still noted right lumbar subcutaneous nodule 18 x 15 mm .

Patient's Name:

SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAD ALL

Date:

2026-04-19

Referred by:

Prof.Dr. CT CAP+C

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

- Small sized right kidney 5 x 2.2 cm with compensatory hypertrophy of left kidney .
- Normal CT appearance of the pancreas, aorta and IVC.
- Normal CT appearance of the spleen .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions ..
- No vertebral structural collapse .

OPINION:.

Overall stationary course

Dr.Reham Khedr, MD

Patient's Name:

SEHAM MOHAMED MOHAMED AWAAD ALLAH

Date:

2026-04-19

Referred by:

Prof.Dr. MRI BRAIN + C

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

MRI OF THE BRAIN WITH CONTRAST

Findings:

- Involutional brain changes in the form of prominent sub arachnoid spaces
- Few foci of altered signal intensity are seen in both frontal regions displaying high T2 & FLAIR signal intensities
- Small area of cystic encephalomalacia is noted at left cerebellar hemisphere .
- Normal size and configuration of the ventricular system with no evidence of deformity or displacement.
- No cerebellar or brain stem areas of abnormal signal intensity
- No mid line shift.
- No extra-axial collections.

● *OPINION:*

Bilateral frontal foci of lacunar infarcts , no evidence of recent ischemic insult

Left cerebellar encephalomalacia .

Dr. Reham khedr ,MD

٢٩٦٢
٢٩٦٢

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



سهايم
محمد محمد عوض الله
قرية امشاليا
مركز العياط - الجيزة

٢٨ ٠١ ٢١ ٠١ ٠١ ٢٢ ٢٢
JP3583155

مكي دلال

الحمد



١١١٣١١١
١٩٨٠

٢٩٦٢



٢٠٢٢/١٠ ٢٢٢٠١٠١٢٠٠١٢٨

بدون عمل



النش
مستلمة
محمود كامل سلامة عبد الحافظ
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١٠/٢٩





مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

/ / 20

٢٦٣٩
٢٠٢٢

Name	فايزة محمد	MRN	٨٣٩٩٤٧٨٣
Age	61y	ID	
Menopausal status		Phone	٠١١٤٦٨٦٦٠٨
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	٠١٤٤٩٩١-٧٩
CO morbidity	HTN	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:	R	L	
ER: -ve	PR: -ve	HER 2: 3+	Ki67: 40%
Sonomammography:			
Mets Workup: Requested			
TNM			

Recommendations: 2014 (P) MRM then Gemzar / Taxol → PORTIT
2016 Cerebellar SOL excised then WBZ 30cy/10fx then Xeloda / Tykerb
1/2017 DP - Re-irradiation (Hoptin / Tykerb / Xeloda) - see Now
CT scan requested

MDT OUTCOME & PLAN

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

**MDT form**

A-Patient ID:

1- Name : سهام محمد محمد عوض الله

Sex:

3- Medical number:

Female

83224783

Old Med :

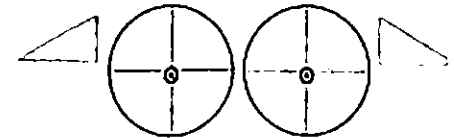
Old Med :

2639-2024

2-ID number:



Patient Age : 63 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

01114686608

BMI

BMI

1

REASON OF MDT

REASON OF MDT
NEW

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

32

GROUP

GROUP

C

Date of MDT

Date Of MDT

09/09/2024 ☐

Co morbidity

Co Morbidity
htnMenopausal
status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
BX COMMENT:	ER COMMENT: -ve	PR COMMENT: -ve	Her 2 Neu COMMENT: +3	SISH COMMENT:	

T	N	M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

2014 RT MRM the n gemzar / taxol-->PORTH

2016 cerebellar sol excised then WBI then xeloda/ tykerb

1/2024 DP-(herceptin/tykerb /xeloda) till now

SHE WAS ON ABOVE MENTIONED TREATMENT SINCE 7 YERAS

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

STOP ALL TREATMENT AND KEEP PATIENT UNDER FOLLOW UP

CT CAP AND MRI BRAIN EVERY 6 MONTHS

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ لؤي الخليم د/ الاء جميل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ مروه ابو السعود د/ احمد ابو السعود
SURGERY	SURGERY د/ عبد المنصور محمد	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition د/ سراء حربي

وحدة دلا لاب الاورام
قسم الباثولوجيا - القصر العيني
ت: 01068529684

IMMUNHISTOPATHOLOGY

Patient Name: سهام محمد محمد

Lab . No:2016-513

Date: 4 /2016

Sex: F

Markers: ER.PR. HER 2 neu and Ki67

Procedure

Sections were prepared from paraffin blocks treated for (ER,PR, HER 2 neu and K167) automatically stained in Benchmark GX(VENTANA) using view dab Detection Kit. Hematoxylin as counter stain

Result

Examination of sections for ER and PR revealed no nuclear staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for HER2 neu revealed positive membranous staining of tumour cells by chromogen

Examination of sections treated for K167 revealed positive nuclear staining about 40% of tumour cells by chromogen

DIAGNOSIS

NEGATIVE FOR ER AND PR
POSITIVE FOR HERZNEU (CLASS 3+) HIGH
PROLIFERATION INDEX

PROF. DR. SAMIA GABAL

اسم المريض ثلاثي:
 رقم الملف:
 ٢٠٢٢



بإمالة
 "مرمل"

Oncology Follow up Sheet

صحيفة متابعة مريض أورام (☐ أطفال / ☐ كبار)

اسم المريض:	
الرقم الطبي:	رقم الملف:
المعاملة المالية:	الرقم القومي:
الطبيب المعالج:	
العنوان الدائم:	
رقم التليفون:	الجنسية:
النوع:	السن:
تاريخ الميلاد:	تاريخ أول زيارة:
كود الأشعة:	

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

PHYSICIAN ASSESSMENT SHEET

I. PERSONAL HISTORY:-

Occupation:
Marital Status : ☐ Married ☐ Single ☐ Widow ☐ Divorced
Special Habits : ☐ Smoking ☐ Coffee ☐ Alcohol ☐ Others
Allergy: ☐ No ☐ Yes - Food: Medications: Others: ☐ Unknown

II. HISTORY:

1.Past History: - ☐ DM ☐ HTN ☐ CLD ☐ IHD ☐ CRD ☐ CVS

☐ Others, specify:

☐ Previous Operations, specify:

☐ Previous Admission to Hospital, ☐ No ☐ Yes Comment

2.Family History:

- Menstrual history : Age at Menarche : / / Y Ferquency : / Days .
- Regular : No / Yes Duration : / Days Pain: No / Yes Discharge: No /
- Menopause: No / Yes Duration : / Y
- History of location:
- History of Miscarriage still birth : No / Yes (Times)
- Children: No. : Sex: Age:

3.Psychological History (Including Emotional/ Behavior/ Social Factors)

4.Current Medication:

Drug	Strength	Dosage/ Frequency	ROUTE

5.Date of First Diagnosis of Cancer

/ / 20

6.Date of First Presentation in Our Unit

/ / 20

7.Present History:

A. The Condition Started by:

..... اسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

for CT scan
- MRI

III. INVESTIGATIONS :

Laboratory Results:

Date: / /20	T BIL:	Creat:
HB:	D Bill:	Urea:
Plt:	AST:	ALP:
WBC: Neut:	ALT:	Ca: K:

Date of Echo: / /20

LVEF= %

➤ Tumor Markers:

➤ Other test:

➤ Pathology and immunohistochemistry

..... اسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Follow up / Progress note

Protocol	Day/week Of Protocol	Temperature	WT:	HT:	Blood Pressure	Blood Sugar
			BSA:			

☒ Treatment

☐ Follow-up

Clinical findings:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

	Doctor Order	الوقت
EF; %	حبلا ولي عه علاج علاج علاج علاج علاج علاج علاج علاج علاج	
BP;		
TEMP;		
HR;		
dB;		
VBC:		
LT:		
JREA:		
CREAT:		
ALT:		
AST:	10/0/2	
T.BIL:		
D.BIL:		

Doctor Signature: Date: / / 20 Time:

وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أودام دار السلام " هرمل "

Protocol	Day/week Of Protocol	Temperature	WT:	HT:	Blood Pressure	Blood Sugar
			BSA:			

Follow-up

she can take 2 meters

	 Amman Medical Center المراكز الطبية المنقططة	الوقت
EF; %		
BP;		
TEMP;		
HR;		
HB;		
WBC:		
PLT:		
UREA:		
CREAT:		
ALT:		
AST:		
T.BIL:		
D.BIL:		

Doctor Signature: **Date:** / / 20 **Time:**

MBC to brain

mdt 9/2024: Stop ALL treatment
Keep on F.U.

CT CAP - MRI every 6m

Pl delayed Reports more than month.

Post pone till

Know the Cause.

افیل + P. دیکسا
لم تهرء. د. زومیتا (ع) ورنید

نی سبب
C. Co / 0 / 57
مراحع انایل

کالسیوم
واند الفنا
نیورفیت
یومیا لیه شهر

ارین هانا
C. Co / 0 / 57

(6/7/2025)

* For New Repats

..... اسم المريض ثلاثي:
..... رقم الملف:



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

Follow up / Progress note

Protocol	Day/week Of Protocol	Temperature	WT:	HT:	Blood Pressure	Blood Sugar
			BSA:			

☐ Treatment

☒ Follow-up

Clinical findings:

Dental clinic
المرضى يحتاجون طعم
والعلاج حسب
.....
.....
.....
.....
.....

	Doctor Order	الوقت
EF; %	07/29	41
BP;	62/29	41
TEMP;		
HR;	08.4	41
HB;	20.25	41
WBC:		
PLT:		
UREA:		
CREAT:		
ALT:		
AST:		
T.BIL:		
D.BIL:		

Doctor Signature: Date: / / 20 Time:

4-8-20

⇒ Bone scan ⇒ R

Dental Consult

Patient Ready for
Zoneda

~~N/2~~
~~C-CO~~

→ Zoneda 4mg. 25. cc sub over 1/4 hr
after 5.00
C

Zoneda 4mg
H.M. Mohamad
4-8

- تم الصرف
1/8 / 1/8

~~5/8~~
4-8-25

- Free occlusion 1/4

13.08
2025 - Complete Mechanical 1/4 W.L. → 21 f3
- relief of occlusion (both was overexposed)
- Dressing & appointment after 10 days
~~1/12~~
~~C-CO~~